

Análisis de los datos

Equipo SILANTRO

Índice

Índice.....	1
1. Variables a tener en cuenta.....	2
2. Datos y cifras por enfermedad.....	2
3. Procedimientos seguidos y evolución de los pacientes.....	5
4. Conclusión.....	6

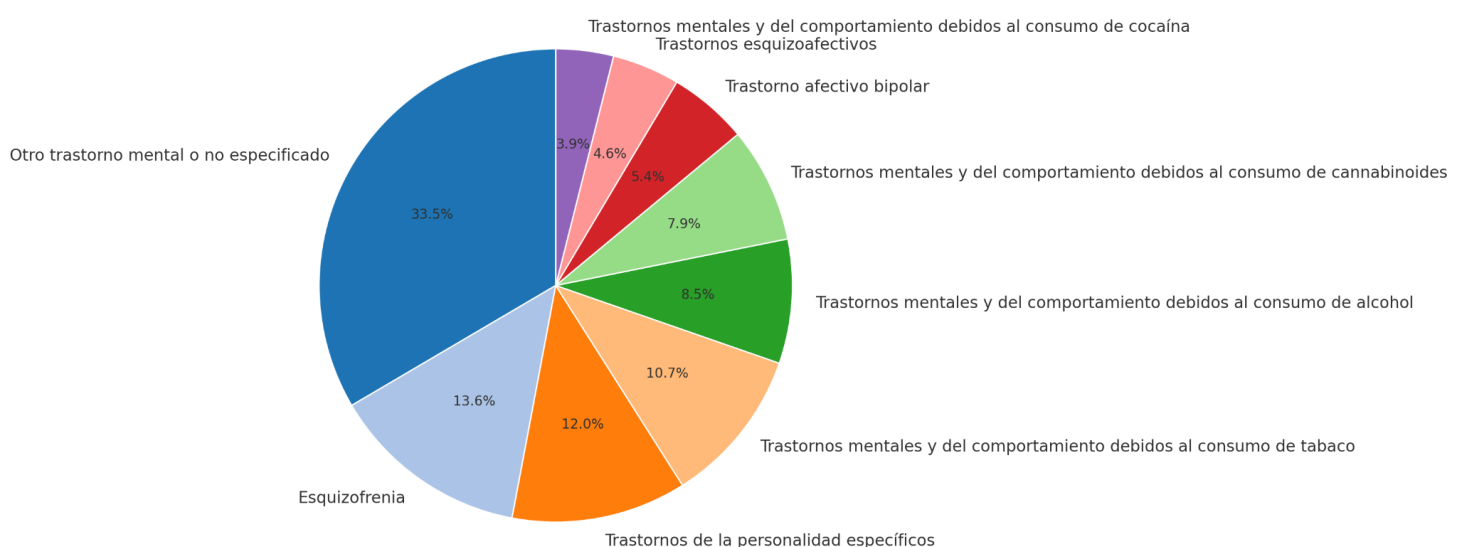
1. Variables a tener en cuenta

En primer lugar, se han seleccionado las variables más relevantes en cuanto al estudio. El análisis va enfocado a la relación entre el diagnóstico y el sexo, edad y lugar de residencia. También se valorará la relación entre diagnósticos principales y posteriores y como las variables afectan a estos.

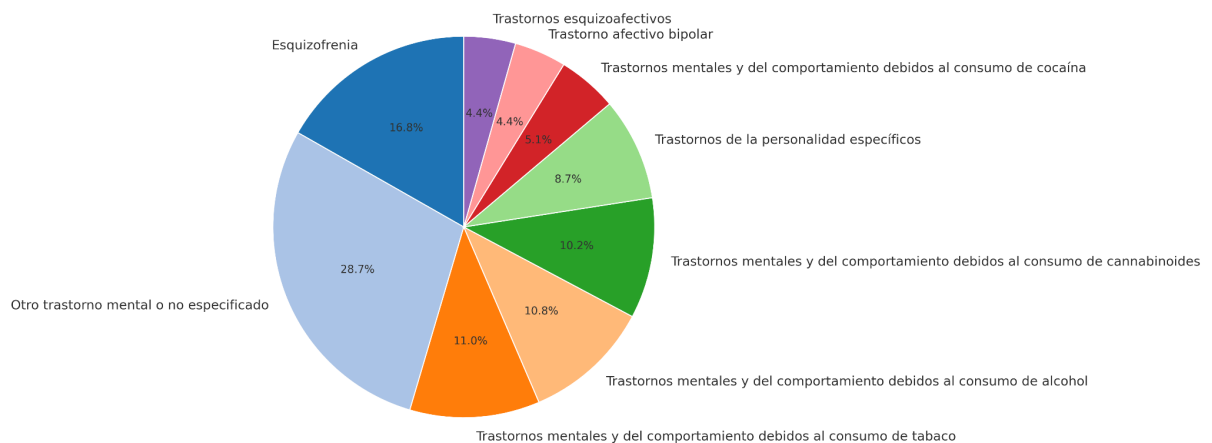
- Edad: Hemos observado que es una característica notoria, apreciando una mayor frecuencia de afecciones como trastornos depresivos en gente mayor de 75, y de trastornos de personalidad específicos en gente de 0 a 17 años. Se han elegido rangos de 0-17, de
- Sexo: Las mujeres padecen con más frecuencia trastornos de personalidad específicos, mientras que los hombres padecen más la esquizofrenia. Además, se ha encontrado que predomina el trastorno de identidad de género en individuos de género no especificado.
- Lugar de residencia: En lo referente a la salud mental, existen tanto enfermedades que tienen una mayor probabilidad no de heredarse en sí, sino de heredar la predisposición a estas.

2. Datos y cifras por enfermedad

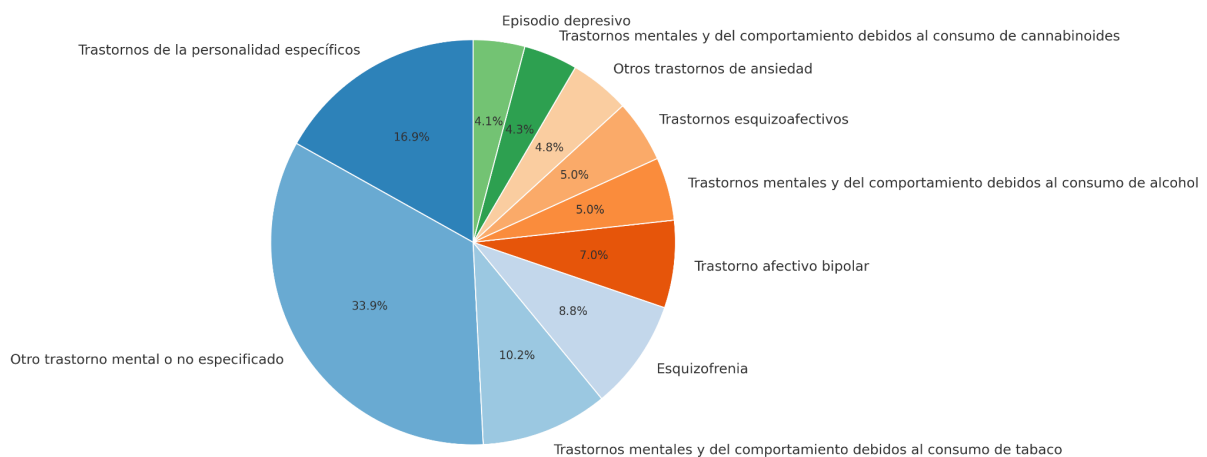
Ahora se procederán a evaluar las enfermedades y su frecuencia según las variables destacadas. Esta es la frecuencia de cada enfermedad por cada 1000 habitantes. Los casos con frecuencia menor a un 3.5% o desconocidos se han agrupado en un apartado llamado "otros".



Como se puede observar, la esquizofrenia es el trastorno más común de toda la muestra, seguidos por los trastornos de la personalidad específicos entre los que se incluyen la bipolaridad o los trastornos de comportamiento causados por el tabaco, como la ansiedad o el síndrome de abstinencia. Ahora observemos las enfermedades con respecto al sexo. Aquí podemos ver el referente a los hombres:



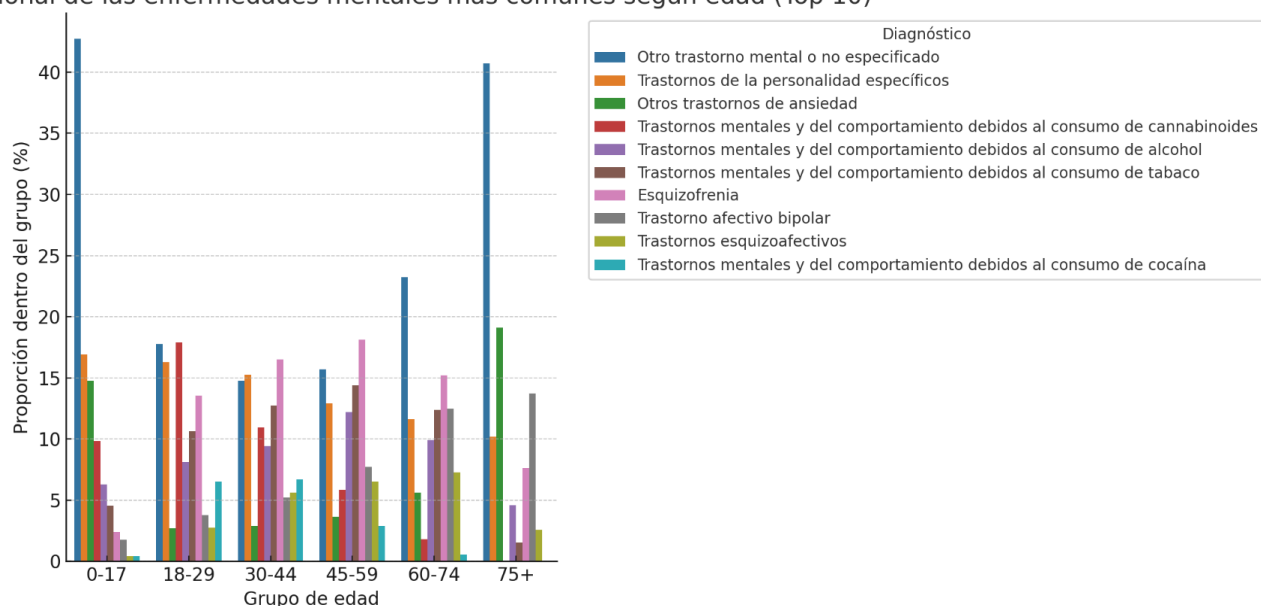
Se puede apreciar que sufren en mayor medida enfermedades relacionadas con las drogas, como el tabaco o el alcohol, obviamente adelantados por la esquizofrenia, que es la más frecuente. Ahora observemos el de las mujeres:



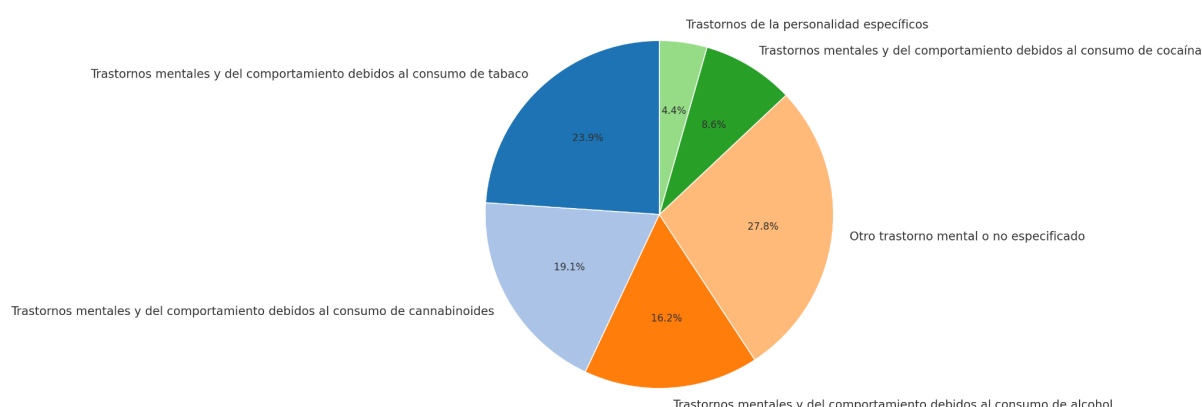
Podemos observar que sufren con más frecuencia trastornos de la bipolaridad y de la personalidad, siendo estos casos más frecuentes que la esquizofrenia. Aunque se ha mencionado antes la utilización de la variable “Lugar de residencia”, en este dataset la mayoría de la muestra reside en Andalucía, así que no merece la pena especificar nada.

Ahora, según la edad. Las barras están dispuestas de forma proporcional, dado que el número de pacientes mayores de 75 años es menor:

Distribución proporcional de las enfermedades mentales más comunes según edad (Top 10)



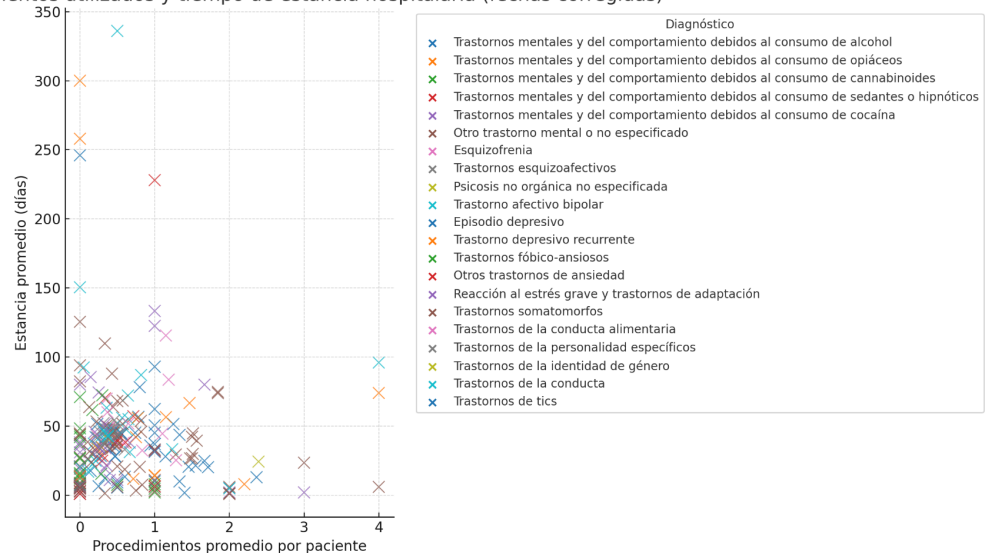
Por último, se proporciona un gráfico que indica la frecuencia de aparición de otros trastornos cuando está presente la esquizofrenia:



Puede verse además que la aparición de trastornos debidos a las drogas, son más frecuentes en la gente con esquizofrenia. Con lo que hemos llegado a algo curioso: **El consumo de drogas es mayor en pacientes con esquizofrenia.**

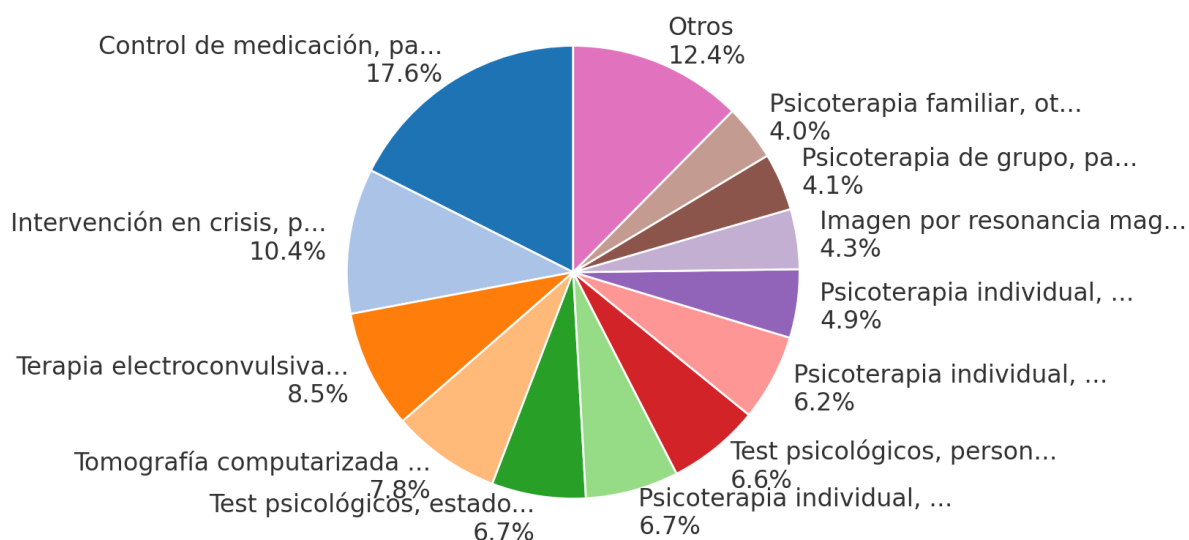
3. Procedimientos seguidos y evolución de los pacientes

Relación entre tratamientos utilizados y tiempo de estancia hospitalaria (fechas corregidas)



Aquí podemos ver un gráfico acerca de la evolución de los pacientes y sus tratamientos. La mayoría de los pacientes no reciben tratamientos, siendo su estancia promedio un mes-mes y medio aproximadamente. El caso que más tratamientos tiene es sorprendentemente el caso de trastorno por consumo de cocaína, empatado con el de la conducta y los opiáceos. Los casos de mayor tiempo de tratamiento son los de bipolaridad, de la depresión y del comportamiento por el consumo de alcohol. La mayoría de los pacientes no reciben tratamiento, o reciben un procedimiento a la vez, y el tiempo más frecuente oscila entre el mes y el mes y medio.

Ahora se muestra un análisis de los procedimientos clínicos más usados:



Entre los tratamientos más frecuentes destacan la psicoterapia individual, el tratamiento farmacológico, la terapia ocupacional, la evaluación psiquiátrica y psicológica, la terapia de grupo y la intervención en crisis, que representan la mayoría de las intervenciones registradas.

El resto de tratamientos, con una frecuencia inferior al 3 %, se han agrupado bajo la categoría “Otros”, que incluye procedimientos complementarios de baja incidencia, como terapias especializadas o técnicas de rehabilitación específicas. Esta agrupación permite visualizar con mayor claridad los enfoques terapéuticos más relevantes dentro de la práctica clínica habitual.

Los resultados reflejan una tendencia a la integración de tratamientos psicológicos, farmacológicos y rehabilitadores, siguiendo un modelo de atención multidisciplinar coherente con las recomendaciones internacionales para el abordaje integral de los trastornos mentales.

4. Conclusión

A lo largo del estudio se ha podido observar una clara relación entre los diagnósticos psiquiátricos y las variables sociodemográficas analizadas. Los resultados muestran una tendencia coherente con la literatura científica actual sobre salud mental, destacando la influencia del sexo, la edad y la comorbilidad entre trastornos.

La esquizofrenia se confirma como la enfermedad más frecuente dentro de la muestra, especialmente en hombres, seguida de los trastornos de la personalidad específicos y los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, entre los

que destacan el tabaco y el alcohol. En las mujeres, sin embargo, prevalecen los trastornos afectivos y de la personalidad, con una mayor proporción de casos de bipolaridad y depresión. Estas diferencias refuerzan la necesidad de enfoques terapéuticos diferenciados según el sexo y la etapa vital del paciente.

Asimismo, se ha constatado que la edad influye significativamente en la aparición de los trastornos: los jóvenes presentan con mayor frecuencia trastornos de conducta y personalidad, mientras que los mayores de 60 años muestran una mayor prevalencia de trastornos afectivos y psicóticos crónicos.

En cuanto a los procedimientos terapéuticos, los datos reflejan un modelo asistencial centrado en la psicoterapia individual y el tratamiento farmacológico, complementado con terapias grupales, ocupacionales y familiares. Sin embargo, destaca que una parte considerable de los pacientes no recibe múltiples intervenciones simultáneas, lo que podría sugerir la necesidad de fortalecer la atención multidisciplinar y los programas de seguimiento.

Por último, el análisis de la comorbilidad en pacientes con esquizofrenia pone de manifiesto la alta asociación entre este trastorno y el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente tabaco y alcohol, lo que evidencia la importancia de integrar estrategias de prevención y deshabituación dentro de los planes de tratamiento psiquiátrico.

En conjunto, los resultados obtenidos subrayan la importancia de un abordaje integral y personalizado de la salud mental, que tenga en cuenta los factores biológicos, psicológicos y sociales, y que priorice tanto la detección precoz como la intervención continuada, garantizando una atención más eficaz y adaptada a las necesidades reales de cada paciente.